

皮皮 體檢對照報告

13 歲 紅貴賓 (公) | 主治醫師：程醫師
比對日期：2026/4/16 vs 2026/5/15 (間隔 29 天)

📋 病史摘要：膽囊黏液囊腫 (GBM) 等待手術中、確診庫欣氏症 (已開始 Trilostane)、嚴重肝膽功能異常、慢性皮膚過敏、預計 6 月中於小花動物醫院進行膽囊切除手術。

基本資料

項目	4/16	5/15	變化
體重	7.20 kg	6.90 kg	↓ 0.30 kg (-4.2%) ⚠️ 需留意

🩸 全血計數 (CBC)

項目	參考值	4/16	5/15	變化解讀
紅血球 RBC	5.65-8.87 M/ μ L	5.21 ↓	6.43	✅ 改善
血球容積比 HCT	37.3-61.7%	35.9 ↓	44.3	✅ 貧血明顯改善
血紅素 HGB	13.1-20.5 g/dL	13.5	15.3	✅ 改善
MCV	61.6-73.5 fL	69.0	68.8	持平
MCH	21.2-25.9 pg	25.9	23.7	改善
MCHC	32.0-37.9 g/dL	37.6	34.5	改善
網織球 RETIC	10-110 K/ μ L	21.5	56.5	✅ 造血反應提升
白血球 WBC	5.05-16.76 K/ μ L	7.42	10.34	↑ 仍在正常範圍
嗜中性球 NEU	2.95-11.64 K/ μ L	5.11	7.45	↑ 正常
淋巴球 LYM	1.05-5.10 K/ μ L	1.20 (低邊)	1.70	改善
單核球 MONO	0.16-1.12 K/ μ L	0.94	1.02	略升
嗜酸性球 EOS	0.06-1.23 K/ μ L	0.16	0.16	持平
血小板 PLT	148-484 K/ μ L	386	480 (上緣)	↑ 邊緣偏高
MPV	8.7-13.2 fL	11.7	11.2	持平
PCT 血小板容積比	0.14-0.46%	未測	0.54 ↑	⚠️ 新增異常 (輕度)

🧪 生化檢驗 — 肝膽功能

項目	參考值	4/16	5/15	變化解讀
ALT 丙胺酸轉氨酶	10-125 U/L	644 ↑	532 ↑	✅ ↓ 17% 改善中
ALKP 鹼性磷酸酶	23-212 U/L	1828 ↑	1690 ↑	↓ 7.5% 微幅改善
GGT	0-11 U/L	未測	125 ↑	⚠️ 新測，顯示嚴重膽汁鬱積
T-Bil 總膽紅素	0-0.9 mg/dL	未列	0.5	🌟 仍在擇期手術窗口
ALB 白蛋白	2.2-3.9 g/dL	3.0	3.0	持平 (偏低邊)

🧪 生化檢驗 — 腎臟功能 (4/16)

項目	參考值	4/16	5/15	備註
BUN 血中尿素氮	7-27 mg/dL	28 ↑	未測	邊緣偏高
CREA 肌酸酐	0.5-1.8 mg/dL	1.2	未測	正常
BUN/CREA	—	23	—	—

⚡ 電解質 — 重點觀察

項目	參考值	4/16	5/15	變化解讀
鈉 Na	144-160 mmol/L	148	150	微升
鉀 K	3.5-5.8 mmol/L	5.0	6.0 ↑	⚠️ 升高超標
Na/K 比值	>27 為安全	30	25 ↓	⚠️ 跨入警戒區
氯 Cl	109-122 mmol/L	109 (下緣)	108 ↓	微降

⚠️ 重要警示：K=6.0 + Na/K=25 + 先前的肌肉抽動症狀，呼應 Trilostane 早期過度抑制（醫源性低皮質醇症）。醫師已將劑量減半處理，建議減量後 7-14 天重驗電解質與 ACTH 刺激試驗，確認穩定。

🔬 生化檢驗 — 蛋白、代謝、其他 (4/16)

項目	參考值	4/16	5/15	備註
TP 總蛋白	5.2-8.2 g/dL	7.7	未測	正常
GLOB 球蛋白	2.5-4.5 g/dL	4.7 ↑	未測	慢性發炎指標
ALB/GLOB 比值	—	0.6	—	偏低
GLU 血糖	70-143 mg/dL	110	未測	正常
CHOL 膽固醇	110-320 mg/dL	305	未測	上緣
TRIG 三酸甘油脂	10-100 mg/dL	>375 ↑↑	未測	● 重度高血脂
CRP 反應蛋白	0.0-1.0 mg/dL	0.1	未測	無急性發炎
胰脂酶	0-200 U/L	118	未測	無胰臟炎
TT4 總甲状腺素	1.0-4.0 µg/dL	<0.5 ↓	未測	庫欣常見假性低下
滲透壓 Osm	—	301 mmol/kg	—	—

🦠 傳染病篩檢 (4/16 SNAP Pro)

項目	結果
無漿體病 (AP_spp)	陰性 ✓
艾利希體病 (EH_spp)	陰性 ✓
心絲蟲	陰性 ✓
萊姆病	陰性 ✓

🎯 整體變化重點解讀

● 好消息 (改善方向)

- 貧血明顯改善 — HCT 35.9 → 44.3，網織球從 21.5 → 56.5K，骨髓造血反應正常啟動。
- 肝指數下降 — ALT ↓ 17%，ALKP ↓ 7.5%，方向正確。
- T-Bil 維持 0.5 — 🌟 最關鍵指標，膽道無阻塞，擇期手術窗口維持中。
- WBC、CRP 正常 — 無全身性感染。
- 傳染病全陰性。

● 中性觀察

1. 體重下降 300g (-4.2%) — 一個月內掉 4% 對 7 公斤老犬需追蹤，可能與食量、Trilostane 影響、或低脂飲食有關。
2. PCT 血小板容積輕微偏高 — 配合 PLT 480K 上緣，可能反映輕微發炎或脫水，對手術反而非壞事（血小板足夠）。

● 需要警覺的點

1. 電解質失衡 — Trilostane 副作用一致
 - K 從 5.0 → 6.0（超標）
 - Na/K 比值從 30 → 25（<27 是醫源性低皮質醇症警訊）
 - 呼應先前的「抽動」副作用
 - ☒ 醫師已減半 Trilostane 劑量處理
2. GGT 125 (>11 倍上限) — 嚴重膽汁鬱積，再次驗證膽囊切除手術的必要性。
3. 三酸甘油酯 >375（重度高血脂） — 庫欣 + 紅貴賓品種 + GBM 的危險組合，飲食控制非常重要。
4. GLOB 4.7（球蛋白偏高） — 慢性發炎刺激，搭配 CRP 正常代表非急性。

📋 給醫師的討論清單

1. 電解質：K=6.0、Na/K=25
 - 是否需減量 Trilostane 後 1-2 週重驗？
 - 是否需考慮暫停 Trilostane？
 - 是否需電解質補充？
2. 重度高血脂 (TRIG >375)：
 - 是否加 Omega-3 魚油？
 - 飼料是否該換成低脂處方（如 RC GI Low Fat）？
3. GGT 125：跟小花術前評估時務必提供此數據。
4. 體重下降 4%：是否需調整熱量攝取或飲食頻次？
5. 下次抽血建議加驗：
 - 凝血功能 PT/aPTT/血小板功能
 - 完整電解質 + 血氣分析
 - cPL（術前胰臟最後確認）

- 重複 T-Bil 確認手術窗口
- ACTH 刺激試驗（劑量調整後）

整體結論

✓ 好的方向

貧血改善、肝指數下降、T-Bil 維持安全、無感染、無傳染病。

⚠ 要警覺的

Trilostane 引起的電解質失衡（醫師已減量處理）、重度高血脂、體重微降。

🎯 手術風險評估：整體仍在「擇期手術窗口」內，5/25 抽膽汁 + 6 月中手術的計畫，目前是合理且安全的。但這段期間請特別注意：抽動有無復發、食慾、活動力。如電解質減量後仍不穩，可能需要更早回診調整。

本報告為個人化健康數據整合，僅供討論參考，所有醫療決策請以執業獸醫師臨床判斷為準。

製作日期：2026/5/16